

SCANNER & IRM PACA

Centre d'Imagerie Médicale
22 avenue Prado
13008 MARSEILLE
Résultats : imagerie-paca.fr
Téléphone : 04.91.00.00.00

Nom : GARCIA
Prénom : Sofia
Date de naissance : 12/09/1985
Sexe : F

Marseille, le 22/04/2026

Dr Nicolas REY
Médecin radiologue

SCANNER ABDOMINO-PELVIEN

Indication :

Douleur abdominale aiguë diffuse avec défense, fièvre à 38,5°C et syndrome inflammatoire biologique. Suspicion de pathologie abdominale aiguë compliquée.

Technique :

Acquisition tomodensitométrie abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisition aux temps portal.
Reconstructions multiplanaires dans les plans axial, sagittal et coronal.
Analyse en fenêtres parenchymateuse, digestive et osseuse.

Résultats :

Tube digestif :

Appendice augmenté de calibre mesurant environ 11 mm de diamètre, à paroi épaissie et rehaussée après injection.
Présence d'un stercolithe appendiculaire hyperdense.

Importante infiltration de la graisse péri-appendiculaire avec épaissement des fascias adjacents.

Présence de bulles d'air extra-luminales en regard de l'appendice, témoignant d'une perforation.

Collection péri-appendiculaire mal limitée, mesurant environ 35 x 28 mm, compatible avec un abcès.

Discrète dilatation des anses grêles adjacentes, traduisant un iléus réactionnel.

Cavité péritonéale :

Présence d'un épanchement liquidien libre modéré au niveau pelvien et des gouttières pariéto-coliques.

Pas de pneumopéritoine massif.

Foie et voies biliaires :

Foie de taille normale, sans lésion focale suspecte.

Voies biliaires non dilatées.

Vésicule biliaire sans anomalie.

Pancréas :

Pancréas d'aspect normal.

Rate :

Rate homogène, de taille normale.

Surrénales :

Sans anomalie.

Reins et voies urinaires :

Reins de morphologie normale, sans dilatation ni lithiase.

Aires ganglionnaires :

Présence de petites adénopathies mésentériques réactionnelles.

Structures osseuses :

Pas d'anomalie osseuse suspecte.

Conclusion :

Aspect de **appendicite aiguë compliquée avec perforation**, associée à une collection péri-appendiculaire compatible avec un abcès.

Présence d'un épanchement péritonéal modéré, sans pneumopéritoine massif.

Tableau compatible avec une **péritonite localisée d'origine appendiculaire**.

Recommandations :

Prise en charge chirurgicale urgente recommandée.

Antibiothérapie probabiliste en pré-opératoire.

Discussion d'un drainage percutané de la collection selon stratégie médico-chirurgicale.